GIÁM SÁT DINH DƯỠNG

TS.BS. NGUYỄN QUANG DŨNG
BỘ MÔN DINH DƯỠNG & ATTP
VIỆN ĐÀO TẠO YHDP & YTCC
ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

MỤC TIÊU BÀI HỌC

- Trình bày được các mục tiêu của giám sát dinh dưỡng
- Trình bày được các nội dung của giám sát dinh dưỡng
- Nêu được các chỉ tiêu trong giám sát dinh dưỡng
- Trình bày được những đặc điểm của giám sát dinh dưỡng trong thời kỳ chuyển tiếp
- Trình bày được 1 số phương pháp giám sát dinh dưỡng

KHÁI NIỆM VÀ MỤC TIÊU CỦA GIÁM SÁT DINH DƯỠNG

3

GIÁM SÁT DINH DƯỠNG LÀ GÌ

- Là một quá trình theo dõi liên tục nhằm mục đích cung cấp những thông tin hiện có về tình hình dinh dưỡng của nhân dân và các yếu tố ảnh hưởng.
- Thông tin này là căn cứ giúp các cơ quan có trách nhiệm về chính sách, kế hoạch, quản lý chương trình có các quyết định thích hợp để cải thiện tiêu thụ thực phẩm và tình trạng dinh dưỡng.

4

MỤC TIÊU CỦA GIÁM SÁT DINH DƯỠNG (1)

- **Mô tả tình hình** dinh dưỡng của nhân dân, đặc biệt nhóm có nguy cơ nhất, cho phép xác định bản chất và mức độ của vấn đề dinh dưỡng, tiến triển của nó.
- **Cung cấp các dẫn liệu** cần thiết để phân tích các nguyên nhân và các yếu tố phối hợp, từ đó lựa chọn các biện pháp dự phòng thích hợp.

5

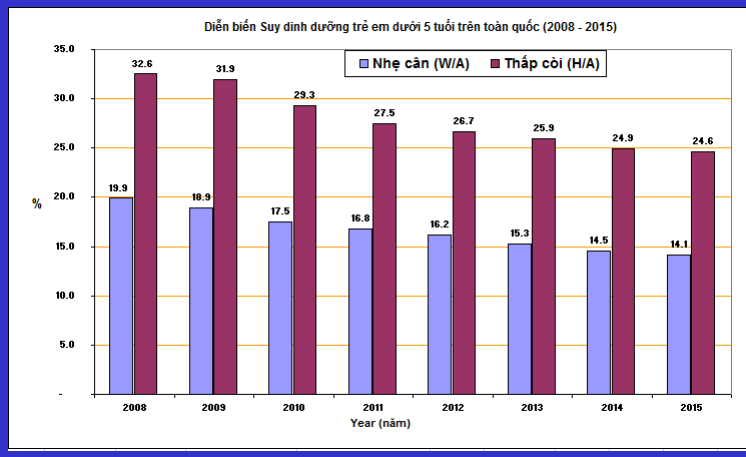
MỤC TIÊU CỦA GIÁM SÁT DINH DƯỠNG (2)

- **Dự báo tiến triển** các vấn đề dinh dưỡng, đề xuất với chính quyền các cấp, nhằm đưa ra đường lối dinh dưỡng thích hợp trong điều kiện bình thường, và tình huống khẩn cấp.
- **Theo dõi thường kỳ** các chương trình can thiệp dinh dưỡng, đánh giá hiệu quả của chúng.

6

DIỄN BIẾN TỶ LỆ SDD TRẺ EM TỪ 2000-2007

DIỄN BIẾN TỶ LỆ SDD TRẺ EM TỪ 2008-2015



NỘI DUNG CỦA GIÁM SÁT DINH DƯỠNG

- Bản chất mức độ và thời gian biểu các vấn đề dinh dưỡng
- Phân lập và mô tả các nhóm nguy cơ nhất
- Phân lập các yếu tố nguyên nhân của suy dinh dưỡng
- Diễn biến theo thời gian của các vấn đề dinh dưỡng

Cùng phân tích ở các slide sau

9

BẢN CHẤT CÁC VẤN ĐỀ DINH DƯỠNG

- Các vấn đề thiếu dinh dưỡng
  - Thiếu năng lượng
  - Thiếu protein
  - Thiếu máu thiếu sắt
  - Thiếu I ốt gây bướu cổ
- Mức độ thiếu không giống nhau: tùy điều kiện sinh thái, sản xuất, tập quán ăn uống
- Thời điểm xảy ra các vấn đề: theo chu kỳ, theo mùa khô, lũ lụt
- Các bệnh mạn tính: cao huyết áp, xơ vữa động mạch, đái tháo đường

10

PHÂN LẬP VÀ MÔ TẢ CÁC NHÓM NGUY CƠ (1)

- Đặc điểm kinh tế xã hội, văn hóa
  - Nhóm nhân chủng học văn hóa
  - Tình trạng kinh tế: thu nhập bình quân, số người trong gia đình
  - Hệ thống phúc lợi xã hội
  - Hệ thống y tế

11

PHÂN LẬP VÀ MÔ TẢ CÁC NHÓM NGUY CƠ (2)

- Đặc điểm cá thể
  - Nhóm tuổi, giới
  - Tình trạng sinh lý: có thai, cho con bú
  - Tiếp xúc với bệnh nhiễm khuẩn
- Đặc điểm vùng miền
  - Nông thôn hay thành phố; Sinh thái: ven biển, miền núi
  - Cung cấp thực phẩm: tự cung tự cấp hoặc sản xuất để bán ra thị trường

12

PHÂN LẬP CÁC YẾU TỐ NGUYÊN NHÂN

- Thực phẩm từ khi sản xuất đến miệng người tiêu thụ có bị ảnh hưởng gì không? Bảo quản, chế biến, lưu thông, tập quán có thể làm ảnh hưởng tới chất lượng dinh dưỡng của TP, dẫn tới SDD
- Giai đoạn ở ngoài gia đình: sản xuất, lưu thông, phân phối, giá cả; giai đoạn ở trong gia đình: cách phân phối, cách chế biến → ảnh hưởng tới chất lượng dinh dưỡng của TP.

13

DIỄN BIẾN THEO THỜI GIAN CÁC VẤN ĐỀ DINH DƯỠNG

- Thay đổi tập quán ăn uống:
  - Từ săn bắn, hái lượm chuyển sang trồng trọt, chăn nuôi
  - Từ tự cung, tự cấp chuyển sang thị trường, công nghiệp chế biến thực phẩm
- Thay đổi cơ cấu bữa ăn: tăng chất béo, chất đạm
- Theo dõi 2 diễn biến chính về vấn đề dinh dưỡng
  - Khả năng và tiến bộ trong phòng chống bệnh thiếu dinh dưỡng
  - Sự gia tăng các bệnh mạn tính không lây liên quan tới dinh dưỡng

14

CÁC CHỈ TIÊU GIÁM SÁT

1. Chỉ tiêu sức khỏe về tình trạng dinh dưỡng
2. Chỉ tiêu kinh tế xã hội về tình trạng dinh dưỡng

Cùng phân tích ở các slide sau

15

CHỈ TIÊU SỨC KHỎE

- Cân nặng sơ sinh
- Cân nặng theo tuổi
- Chiều cao theo tuổi
- Vòng cánh tay
- Tỷ lệ tử vong
  - Trẻ 0-1 tuổi: số trẻ tử vong trên 1000 trẻ sơ sinh sống
  - Trẻ 1-4 tuổi: số trẻ 1-4 tuổi tử vong trên 1000 trẻ cùng nhóm tuổi

16

CHỈ TIÊU KINH TẾ XÃ HỘI (1)

Khu vực nông thôn:

- Lượng mưa
- Diện tích canh tác
- Sản lượng lương thực
- Kho dự trữ lương thực hộ gia đình
- Sâu hại cây trồng
- Bệnh tật gia súc, gia cầm
- Số lượng, chủng loại gia súc, sinh sản của gia súc, gia cầm
- Thuyền đánh cá

17

CHỈ TIÊU KINH TẾ XÃ HỘI (2)

Khu vực thành phố- ngoại thành

- Công ăn việc làm như thế nào
- Giá một suất ăn so với thu nhập

18

GIÁM SÁT DINH DƯỠNG TRONG THỜI KỲ CHUYỂN TIẾP

- Đặc điểm dân số: số người già tăng lên, trẻ em sinh ra ít hơn
- Đặc điểm dịch tễ học: Thay đổi mô hình bệnh: bệnh nhiễm trùng giảm, bệnh mạn tính không lây tăng lên.
- Giám sát các chỉ tiêu trong bệnh mạn tính bao gồm:
  - Giám sát yếu tố ăn uống
  - Giám sát các chỉ tiêu sức khỏe trung gian
  - Giám sát bệnh tật
  - Giám sát tử vong

Cùng phân tích ở các slide sau

GIÁM SÁT YẾU TỐ ĂN UỐNG

- Năng lượng tổng số (kcal)
- Lipid tổng số và % năng lượng do Lipid cung cấp
- Lipid động vật/Lipid tổng số (%)
- Glucid tổng số và % năng lượng do Glucid cung cấp
- Chất xơ
- Đường
- Chất chống ô xy hóa: Vitamin A, C, E, beta-carotene
- Muối

GIÁM SÁT CHỈ TIÊU SỨC KHỎE TRUNG GIAN

- Béo phì
- Cholesterol
- Huyết áp
- Glucose máu

21

GIÁM SÁT BỆNH TẬT

- Bệnh tim mạch, bệnh mạch vành
- Cao huyết áp
- Đột quỵ
- Ung thư
- Đái tháo đường
- Sâu răng

22

TÀI LIỆU THAM KHẢO QUỐC TẾ

23

GIÁM SÁT DỊCH TỄ HỌC

Giám sát dịch tễ là sự đánh giá tỉ mỉ và liên tục tất cả các yếu tố dẫn tới sự xuất hiện, sự lây lan dịch bệnh và tình trạng bệnh. Giám sát dịch tễ đóng vai trò quan trọng trong phòng chống bệnh tật, bao gồm việc thu thập, phân tích, phiên giải và phổ biến dữ liệu.

24

GIÁM SÁT DINH DƯỠNG LÀ GÌ (1)

FAO/UNICEF/WHO 1976:
Là một quá trình theo dõi liên tục nhằm mục đích cung cấp những thông tin hiện có về tình hình dinh dưỡng của nhân dân và các yếu tố ảnh hưởng. Thông tin này là căn cứ giúp các cơ quan có trách nhiệm về chính sách, kế hoạch, quản lý chương trình có các quyết định thích hợp để cải thiện tiêu thụ thực phẩm và tình trạng dinh dưỡng.

25

GIÁM SÁT DINH DƯỠNG LÀ GÌ (2)

World Food Conference 1974:
"Hệ thống thu thập thông tin liên tục về tình trạng dinh dưỡng hiện tại, tương lai, sự phân bố và các nguyên nhân của suy dinh dưỡng trong quần thể, nhằm xây dựng chính sách, lập kế hoạch, quản lý và đánh giá các chương trình"

26

GIÁM SÁT DINH DƯỠNG LÀ GÌ (3)

- Giám sát dinh dưỡng là quá trình theo dõi khuynh hướng về tình hình dinh dưỡng theo thời gian nhằm giúp đưa ra quyết định.
- Giám sát dinh dưỡng **không nhất thiết tạo ra hành động**, mà là:
  - Đưa ra quyết định khi nào cần hành động,
  - Hướng dẫn lựa chọn hành động như việc sửa đổi chính sách, đề xuất một chương trình, thay đổi một chương trình hiện tại.

27

"GIÁM SÁT" VÀ "HỆ THỐNG GIÁM SÁT"

- **"Giám sát"**: là một hoạt động nói chung,
- **"Hệ thống giám sát"** là một quá trình cụ thể nằm trong hoạt động "giám sát".
- **"Giám sát dinh dưỡng"**: Việc thu thập dữ liệu về các chỉ tiêu dinh dưỡng một cách hệ thống và thường xuyên.
- **"Hệ thống giám sát dinh dưỡng"**: Một hệ thống do một cơ quan trung ương điều phối, tiến hành thu thập dữ liệu sơ cấp mang tính đại diện thống kê của quần thể theo một khoảng thời gian định kỳ về các chỉ tiêu dinh dưỡng và các yếu tố ảnh hưởng, nhằm trợ giúp việc ra quyết định.

28

PHÂN BIỆT GIỮA HỆ THỐNG THÔNG TIN DINH DƯỠNG VÀ HỆ THỐNG GIÁM SÁT DINH DƯỠNG

- **"Hệ thống thông tin dinh dưỡng"**: tập hợp phần cứng, phần mềm, dữ liệu, con người, quy trình giúp tạo ra thông tin.
- **"Giám sát dinh dưỡng"** là một thành phần của **"hệ thống thông tin dinh dưỡng"**.
- Ví dụ tương tự: "Giám sát tình hình sức khỏe" là một thành phần của "hệ thống thông tin sức khỏe".

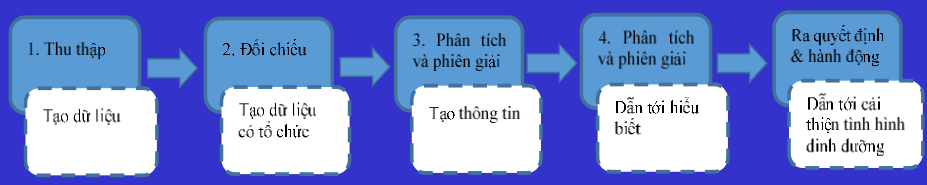
29

"ĐIỀU TRA" VÀ "GIÁM SÁT TRỌNG ĐIỂM"

- **"Điều tra"**: phương pháp thu thập thông tin từ một mẫu của quần thể, nhằm mô tả định lượng các thuộc tính của quần thể lớn hơn. Đặc trưng chính của điều tra là việc khái quát kết quả, mẫu điều tra phải đảm bảo tính đại diện.
- **"Giám sát trọng điểm"**- sentinel surveillance: Việc thu thập dữ liệu được lấy từ các mẫu điều tra cỡ nhỏ, do đó những phát hiện từ giám sát trọng điểm không mang tính đại diện cho một quần thể lớn hơn, nó chỉ hữu ích cho việc phân tích xu hướng.

30

BỐN GIAI ĐOẠN CỦA QUÁ TRÌNH GIÁM SÁT VÀ CÁC SẢN PHẨM TẠO RA Ở MỖI GIAI ĐOẠN



31

VÍ DỤ HỆ THỐNG GIÁM SÁT DINH DƯỠNG

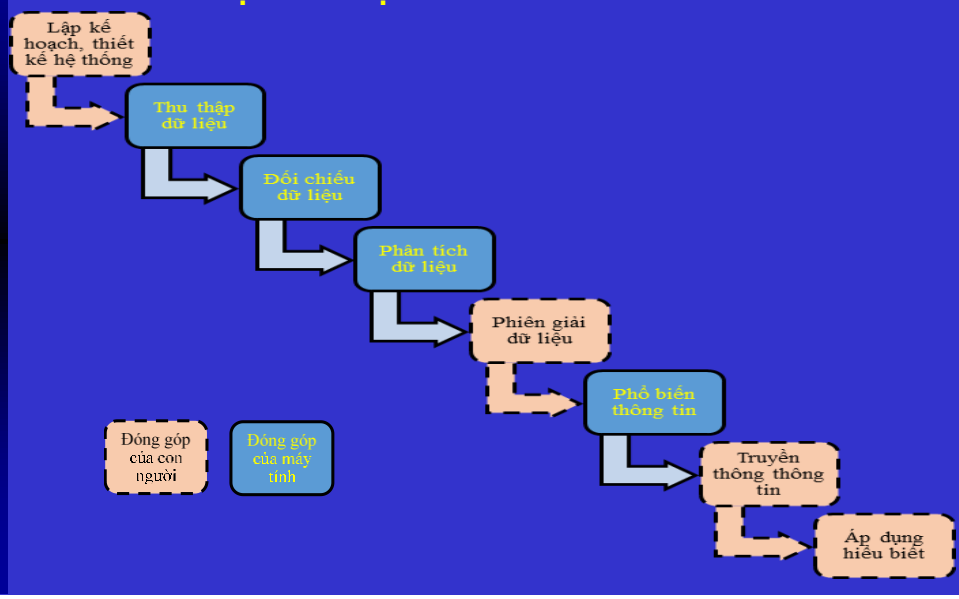
- Tại Ethiopia: Các cuộc điều tra lặp lại 6 tháng/1 lần là một hệ thống giám sát dinh dưỡng, góp phần vào hệ thống thông tin của cơ quan điều phối dinh dưỡng khẩn cấp.
- Tại Việt Nam: Điều tra giám sát 30 cụm hàng năm cũng là một hệ thống giám sát dinh dưỡng, góp phần vào hệ thống thông tin sức khỏe của Bộ y tế.

32

CẢI TIẾN CÔNG NGHỆ THU THẬP SỐ LIỆU

- 1980: Dữ liệu vệ tinh hỗ trợ giám sát an ninh lương thực
- 1990: Phỏng vấn có sự hỗ trợ của máy tính
- Đầu thế kỷ 21: phỏng vấn sử dụng điện thoại thông minh smart phone, công nghệ “real time monitoring”.
- Mặc dù có sự trợ giúp của công nghệ, nhưng vẫn cần có sự tham gia của con người trong 1 vài khâu: do đó vẫn tồn tại những sai số nhất định, ngay cả ở các nước phát triển cũng gặp vấn đề này.

VAI TRÒ CỦA CON NGƯỜI VÀ MÁY TÍNH TRONG THU THẬP DỮ LIỆU GIÁM SÁT DINH DƯỠNG



CHỨC NĂNG CỦA GIÁM SÁT (1)

- Cảnh báo kịp thời nhằm đề phòng nạn đói và mất an ninh lương thực
- Hỗ trợ cho việc lập kế hoạch và xây dựng chính sách, nhằm theo dõi và củng cố tác động của chính sách dinh dưỡng.
- Theo dõi và đánh giá chương trình dinh dưỡng
- Theo dõi hoạt động bồi thường từ các chính sách điều chỉnh kinh tế

35

CHỨC NĂNG CỦA GIÁM SÁT (2)

- Xác định vấn đề cho vận động chính sách, ý kiến công luận, cung cấp thông tin cho người ra quyết định
- Gắn kết việc giám sát trong khuôn khổ dựa vào cộng đồng nhằm huy động và thúc đẩy hành động ở cấp địa phương
- Nghiên cứu nguyên nhân các vấn đề dinh dưỡng

36

MỤC TIÊU CỦA GIÁM SÁT DINH DƯỠNG (1)

- Giám sát dinh dưỡng có 4 mục tiêu chính sau
  - Thiết kế chương trình
  - Quản lý và đánh giá chương trình.
  - Xây dựng chính sách
  - Quản lý nguy cơ

37

MỤC TIÊU CỦA GIÁM SÁT DINH DƯỠNG (1)

- Các mục tiêu trên bao gồm
  - Cảnh báo sớm khủng hoảng lương thực/thực phẩm;
  - Tiến hành can thiệp đặc hiệu;
  - Theo dõi & đánh giá chương trình dinh dưỡng;
  - Xây dựng năng lực cá thể, hộ gia đình, cộng đồng để quản lý vấn đề dinh dưỡng;
  - Chính sách và vận động sự ủng hộ tầm vĩ mô và quy mô quốc tế.

38

SỬ DỤNG THÔNG TIN GIÁM SÁT DINH DƯỠNG ĐỂ LÀM GÌ

- Theo dõi tình hình dinh dưỡng
- Xác định các yếu tố liên quan tới suy dinh dưỡng
- Thông tin về các chương trình và chính sách dinh dưỡng
- Theo dõi tiến độ đạt các mục tiêu về dinh dưỡng
- Đưa ra cảnh báo sớm về sự gia tăng nguy cơ dinh dưỡng
- Đánh giá về việc cung cấp và độ bao phủ các dịch vụ
- Đánh giá chương trình và các can thiệp
- Phát hiện sự tác động do thay đổi các chính sách

39

PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG ĐỂ GIÁM SÁT DINH DƯỠNG

- Điều tra lặp lại-repeated survey
- Theo dõi tăng trưởng-growth monitoring
- Giám sát trọng điểm-sentinel site surveillance
- Dữ liệu điều tra trường học-School census data

Cùng phân tích ở các slide sau

40

ĐIỀU TRA LẶP LẠI

- Là các cuộc điều tra quần thể mang tính đại diện được thực hiện theo một khoảng thời gian nhất định.
  - Điều tra Dân số và Sức khỏe-Demographic Health Surveys-DHS
  - Điều tra "Multiple Indicator Cluster Surveys"-MICS của Unicef
  - Điều tra "Living Standards Measurement Surveys"-LSMS của World Bank.
  - Điều tra quy mô nhỏ nhằm đưa ra hướng dẫn cho các chương trình liên quan tới dinh dưỡng.

41

ƯU ĐIỂM CỦA ĐIỀU TRA LẶP LẠI Ở QUY MÔ QUỐC GIA

- Đại diện cho quần thể.
- Có thể dùng để đánh giá chính sách vĩ mô, tác động của các chương trình dinh dưỡng cấp quốc gia
- Xác định được vùng địa lý để định hướng can thiệp dựa trên tiêu chí là vùng có tỷ lệ SDD cao.

42

NHƯỢC ĐIỂM CỦA
ĐIỀU TRA LẶP LẠI Ở QUY MÔ QUỐC GIA

- Chi phí triển khai đắt đỏ.
- Thường xuyên thiếu thông tin theo ngữ cảnh
- Có thể không bao gồm một số nhóm quần thể
- Không có khả năng phân tách dữ liệu trên cơ sở giới tính và các nhóm kinh tế xã hội

43

ƯU ĐIỂM CỦA
ĐIỀU TRA LẶP LẠI Ở QUY MÔ NHỎ

- Việc triển khai và phân tích dữ liệu diễn ra nhanh chóng.
- Trong tình huống khẩn cấp, thông tin về SDD cấp tính được dùng để tiến hành can thiệp cụ thể.

44

NHƯỢC ĐIỂM CỦA ĐIỀU TRA LẶP LẠI Ở QUY MÔ NHỎ (1)

- Dữ liệu tách rời, không đủ căn cứ để tiến hành can thiệp cho một nhóm quần thể
- Nếu điều tra trên cộng đồng phân tán rộng: tốn thời gian, nguồn nhân lực
- Tại khu vực không đảm bảo an toàn (nội chiến…), rất khó thu thập các mẫu đại diện cho quần thể.

45

NHƯỢC ĐIỂM CỦA ĐIỀU TRA LẶP LẠI Ở QUY MÔ NHỎ (2)

- Nếu thông tin chỉ giới hạn về chỉ tiêu nhân trắc, điều tra sẽ thiếu thông tin bối cảnh khác như an ninh lương thực, các nhóm sinh kế, tiếp cận dịch vụ công.
- Phương pháp sử dụng trong điều tra quy mô nhỏ thường không chuẩn, gây khó khăn cho việc so sánh dữ liệu giữa các cuộc điều tra theo thời gian.

46

THEO DÕI TĂNG TRƯỞNG (1)

- Là việc theo dõi liên tục quá trình tăng trưởng cơ thể, thường là cân nặng theo tuổi.
- Được thực hiện bởi cán bộ trạm y tế xã, trung tâm y tế huyện/tỉnh, trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh/huyện.
- Mục đích nhằm theo dõi và quản lý TTDD của trẻ và huy động các nguồn lực địa phương, hỗ trợ cho các hoạt động liên quan tới dinh dưỡng.

47

THEO DÕI TĂNG TRƯỞNG (2)

- Gồm 2 loại:
  - Theo dõi tăng trưởng dựa vào cơ sở y tế
  - Theo dõi tăng trưởng dựa vào cộng đồng

Cùng phân tích ưu, nhược của 2 phương pháp ở các slide sau

48

ƯU ĐIỂM
CỦA THEO DÕI TĂNG TRƯỞNG DỰA VÀO CƠ SỞ Y TẾ (1)

- Có điểm mạnh là thu thập dữ liệu thường xuyên dựa vào nguồn dữ liệu TTDD sẵn có ở cấp quốc gia.
- Là nguồn thông tin về xu hướng dinh dưỡng, cho phép so sánh giữa các vùng địa lý.
- Dựa trên việc xác định các vùng địa lý có nguy cơ, giúp đưa ra các quyết định can thiệp.
- Hữu ích trong tình huống khẩn cấp, nơi điều kiện an ninh không đảm bảo, không thể tiến hành điều tra được.

49

NHƯỢC ĐIỂM
CỦA THEO DÕI TĂNG TRƯỞNG DỰA VÀO CƠ SỞ Y TẾ (2)

Quần thể khảo sát tại cơ sở y tế không đại diện cho toàn bộ dân số, lý do như sau:

- Chỉ có những trẻ khỏe mạnh tới trạm y tế để cân đo
- Số lượng trẻ trên 1 tuổi tới trạm y tế sẽ ít đi do việc tiêm chủng đã hoàn tất, và bà mẹ không thấy cần thiết phải đến trạm.
- Việc cân đo tại trạm y tế có thể không chính xác

50

ƯU ĐIỂM
CỦA THEO DÕI TĂNG TRƯỞNG DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG

- Được các tổ chức UNICEF, NGOs, World Bank hỗ trợ.
- Trao quyền cho cộng đồng được thu thập, phiên giải các thông tin dinh dưỡng
- Hệ thống theo dõi tăng trưởng dựa vào cộng đồng hoạt động tốt khi có đủ nguồn lực, có sự đào tạo, sự hỗ trợ, cho phép cộng đồng tự giải quyết các vấn đề dinh dưỡng.

51

NHƯỢC ĐIỂM
CỦA THEO DÕI TĂNG TRƯỞNG DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG

- Độ chính xác của dữ liệu chưa đảm bảo.
- Chậm chễ trong việc phân tích số liệu
- Thiếu thông tin hoàn cảnh để bổ sung cho dữ liệu theo dõi tăng trưởng
- Khó khăn trong việc đảm bảo thông tin sẽ nhận được sự quan tâm của chính quyền cấp huyện/tỉnh/vùng.

52

GIÁM SÁT TRỌNG ĐIỂM LÀ GÌ

- Giám sát trọng điểm là sự theo dõi chủ đích các cộng đồng hoặc các điểm cung cấp dịch vụ nhằm phát hiện sự thay đổi bối cảnh, chương trình, kết quả.
- Các địa điểm được chọn chủ đích bởi các lý do: 1) là nơi áp dụng phương pháp trồng trọt cải tiến; 2) là nơi mất an ninh lương thực.
- Điều tra dịch tễ đối với quần thể nhỏ nhằm phát hiện vấn đề sức khỏe, sự kiện cần can thiệp đặc hiệu.
- Phạm vị nhỏ, chi phí rẻ hơn, ít phức tạp hơn, nhưng không mang tính đại diện toàn bộ quần thể

53

HÌNH THỨC GIẢM SÁT TRỌNG ĐIỂM

Có 2 hình thức giám sát trọng điểm:

- Giám sát trọng điểm do trung ương thực hiện
- Giám sát trọng điểm do cộng đồng thực hiên

54

ƯU ĐIỂM CỦA GIÁM SÁT TRỌNG ĐIỂM DO TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN

- Chi phí rẻ hơn so với điều tra quốc gia
- Cung cấp thông tin sâu hơn về nguyên nhân suy dinh dưỡng
- Điều tra viên dành nhiều thời gian tại cộng đồng, phản hồi nhanh tới cộng đồng
- Đưa ra cảnh báo sớm về các khủng hoảng có thể xảy ra.

55

NHƯỢC ĐIỂM CỦA GIÁM SÁT TRỌNG ĐIỂM DO TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN

- Thiếu các nhóm quần thể cần phải quan tâm, nhưng lại không được chọn cho giám sát.
- Dữ liệu thu được không mang tính đại diện
- Dữ liệu có thể không so sánh được với các cuộc điều tra khác

56

ƯU ĐIỂM CỦA GIÁM SÁT TRỌNG ĐIỂM DO CỘNG ĐỒNG THỰC HIỆN

- Có sự trao quyền cho cộng đồng.
- Chi phí rẻ hơn so với giám sát trọng điểm do trung ương thực hiện
- Cách giám sát này phù hợp trong tình huống khẩn cấp khi tình trạng mất an ninh không cho phép chọn mẫu đại diện.

57

NHƯỢC ĐIỂM CỦA GIÁM SÁT TRỌNG ĐIỂM DO CỘNG ĐỒNG THỰC HIỆN

- Vùng lựa chọn có thể không đại diện cho toàn bộ quần thể.
- Chất lượng dữ liệu có thể chưa cao, nên không được sử dụng cho việc ra quyết định.
- Người thu thập dữ liệu có thể không được nhận thù lao.

58

BẢNG SO SÁNH 2 LOẠI GIÁM SÁT TRỌNG ĐIỂM

	Trung ương	Cộng đồng
Mô tả	• Điểm giám sát trọng điểm được chọn chủ đích là vùng có nguy cơ cao • Dữ liệu được đối chiếu và phân tích bởi trung ương và cộng đồng	
	• Dữ liệu được đối chiếu và phân tích bởi tuyến trung ương • Có thể có sự tham gia của cộng đồng	• Dữ liệu được đối chiếu và phân tích bởi nhân viên đã được đào tạo ở cộng đồng
Mục đích	Theo dõi và đánh giá TTDD	
Mục tiêu	• Phát hiện sự thay đổi hoàn cảnh, chương trình, biến số đầu ra • Đưa ra cảnh báo và phân tích xu hướng	
	• Liên tục theo dõi sự ra đời các chính sách, xác dịnh cơ chế trong đó các dịch vụ được cung cấp hiệu quả nhất	• Cung cấp thông tin nhanh liên quan tới sức khỏe, dinh dưỡng trong cộng đồng • Chỉ ra sự thay đổi theo thời gian và các hành động can thiệp được giải quyết tại địa phương

SO SÁNH 2 LOẠI GIÁM SÁT TRỌNG ĐIỂM

	Trung ương thực hiện	Cộng đồng thực hiện
Ưu điểm	• Tốn ít chi phí so với điều tra quốc gia • Có thể tiến hành điều tra thống kê • Tìm ra được nhiều thông tin sâu hơn về nguyên nhân suy dinh dưỡng • Người thu thập dữ liệu có mặt một thời kỳ dài tại cộng đồng, nhận phản hồi nhanh từ cộng đồng • Đưa ra cảnh báo sớm về nơi có nguy cơ nhất • Quan sát khuynh hướng các chỉ tiêu dinh dưỡng, chỉ ra địa điểm để tiếp tục theo dõi	• Trao quyền cho cộng đồng • Chi phí rẻ hơn so với hệ thống giám sát điểm do trung ương thực hiện • Hữu ích trong tình huống khẩn cấp, khi tình trạng mất an ninh không cho phép chọn mẫu đại diện

SO SÁNH 2 LOẠI GIÁM SÁT TRỌNG ĐIỂM

	Trung ương thực hiện	Cộng đồng thực hiện
Nhược điểm	• Dữ liệu không đại diện cho quần thể rộng hơn và không khái quát • Nhóm quần thể đáng quan tâm lại không được chọn • Dữ liệu không thể so sánh với điều tra khác	• Vùng lựa chọn có thể không đại diện cho quần thể lớn hơn • Chất lượng dữ liệu chưa tin cậy • Người thu thập dữ liệu có thể không được nhận thù lao.

61

DỮ LIỆU ĐIỀU TRA TRƯỜNG HỌC

- Giám sát các chỉ tiêu dinh dưỡng đôi khi được tiến hành tại trường học.
- Chỉ số chiều cao theo tuổi, thấp còi được giám sát 2-3 năm/lần.
- Nhằm xác định quần thể nguy cơ cao với sức khỏe kém, suy dinh dưỡng, tình trạng kinh tế xã hội thấp.

62

BỐN YẾU TỐ CHÍNH QUYẾT ĐỊNH TÍNH PHÙ HỢP VÀ KHẢ THI CỦA PHƯƠNG PHÁP GIÁM SÁT DINH DƯỠNG (1)

- Mục tiêu của hệ thống
- Chi phí và sự sẵn có của các nguồn lực
- Khả năng xử lý
- Yếu tố môi trường

Cùng phân tích ở các slide sau

63

BỐN YẾU TỐ CHÍNH QUYẾT ĐỊNH TÍNH PHÙ HỢP VÀ KHẢ THI CỦA PHƯƠNG PHÁP GIÁM SÁT DINH DƯỠNG (2)

- **Mục tiêu của hệ thống:**
  - Nếu mục tiêu là đưa ra quyết định ở cấp quốc gia thì điều tra quốc gia là phương pháp phù hợp.
  - Nếu mục tiêu là hỗ trợ gia đình trong phòng chống SDD thì "theo dõi tăng trưởng dựa vào cơ sở y tế, dựa vào cộng đồng" là phương pháp phù hợp.
- **Chi phí và sự sẵn có của các nguồn lực:** Điều tra quốc gia thường tốn kém hơn so với giám sát dựa vào cộng đồng.

64

BỐN YẾU TỐ CHÍNH QUYẾT ĐỊNH TÍNH PHÙ HỢP VÀ KHẢ THI CỦA PHƯƠNG PHÁP GIÁM SÁT DINH DƯỠNG (3)

- **Khả năng xử lý:** lựa chọn phương pháp phụ thuộc vào mục tiêu nâng cao khả năng ra quyết định ở các cấp khác nhau: cấp hộ gia đình, cộng đồng, huyện, quốc gia, quốc tế, có sự khác biệt rất lớn về khả năng xử lý vấn đề giữa các quốc gia, giữa các khu vực.
- **Yếu tố môi trường:** An ninh, địa hình địa lý, cơ sở hạ tầng là yếu tố cần chú ý. An ninh kém làm ảnh hưởng tới chọn mẫu đại diện, do đó điều tra quốc gia sẽ không khả thi, cơ sở hạ tầng kém, điều kiện địa hình khó khăn làm ảnh hưởng việc thu thập số liệu.

65

CÁC CƠ QUAN LIÊN QUAN TỚI DỮ LIỆU GIÁM SÁT

Cơ quan	Mục đích sử dụng
Chính phủ	- Dinh dưỡng: hướng dẫn quốc gia về dinh dưỡng & thực phẩm, giá trị tham chiếu thực phẩm, chiến lược dinh dưỡng, mục đích - Y tế: bệnh mạn tính, bất bình đẳng, nhóm quần thể - Thực phẩm: giám sát tiêu chuẩn thực phẩm (an toàn thực phẩm, thành phần, nhãn)
Ngành y tế	Chương trình (giáo dục dinh dưỡng, nâng cao sức khỏe, an toàn thực phẩm), dịch vụ, tư vấn bệnh nhân
NGOs	Chính sách, chương trình,
Viện nghiên cứu	Giảng dạy, định hướng nghiên cứu, dữ liệu cho nghiên cứu
Công nghiệp thực phẩm	Dán nhãn, tiếp thị thực phẩm
Công chúng	Thông tin, lời khuyên, giáo dục

66

SỬ DỤNG CHỈ TIÊU DINH DƯỠNG TRONG HỆ THỐNG GIÁM SÁT

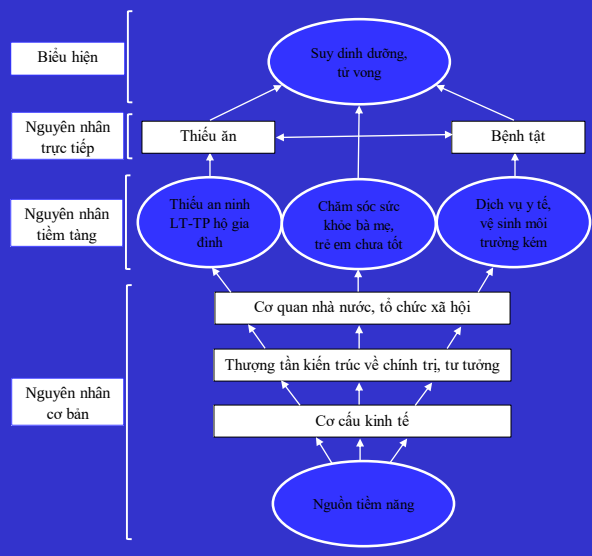
67

LIÊN QUAN GIỮA TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG VÀ AN NINH LƯƠNG THỰC VÀ ĐÓI NGHÈO (1)

- Mô hình nguyên nhân SDD của UNICEF: SDD, tử vong là hậu quả cuối cùng các nguyên nhân trực tiếp, cơ bản, tiềm tàng.
- Nguyên nhân trực tiếp là thiếu ăn và bệnh tật
- Nguyên nhân cơ bản là thiếu an ninh lương thực hộ gia đình, chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em kém, dịch vụ y tế và môi trường kém.
- Nguyên nhân tiềm tàng: Cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, thượng tầng kiến trúc tư tưởng và chính trị, cơ cấu kinh tế, nguồn tiềm năng.

68

MÔ HÌNH NGUYÊN NHÂN SUY DINH DƯỠNG CỦA UNICEF



69

LIÊN QUAN GIỮA TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG VÀ AN NINH LƯƠNG THỰC VÀ ĐÓI NGHÈO (2)

- Cần chú ý thu thập thêm thông tin về sinh kế, thực hành chăm sóc sức khỏe.
- Dữ liệu sức khỏe được thu thập dễ dàng từ các chương trình giám sát tăng trưởng triển khai tại trạm y tế/trung tâm y tế, do nhân viên y tế thường xuyên có mặt.
- Dữ liệu sinh kế, an ninh lương thực dễ dàng được thu thập từ giám sát trọng điểm.

70

CÁC CHỈ TIÊU KHÁC GÌ NHAU

- Chỉ tiêu được chia thành 3 loại: kết quả, quá trình và bối cảnh.
  - **"Kết quả"** chỉ ra sự thay đổi tỷ lệ ở mức quần thể: như tỷ lệ SDD cấp tính, cân nặng sơ sinh thấp, do đó nó phản ánh nguyên nhân trực tiếp của SDD.
  - **"Quá trình"** đề cập tới các hoạt động của chương trình như độ bao phủ, chất lượng.
  - **"Bối cảnh"** phản ánh nguyên nhân tiềm tàng và cơ bản của SDD như: trình độ học vấn phụ nữ, chất lượng và bao phủ của dịch vụ y tế.
  - Nhu vậy, Tình trạng dinh dưỡng là chỉ số về "kết quả"

71

THÔNG TIN CẦN THU THẬP TRONG GIÁM SÁT

- Sinh thái: Khí tượng, đất, nước, thực vật, dân số
- Cơ sở hạ tầng: giao thông, truyền thông, dịch vụ
- Nguồn lực và sản xuất: nông nghiệp, chăn nuôi, xuất nhập khẩu thực phẩm, dữ trự thực phẩm, nhiên liệu
- Thu nhập và tiêu thụ: dữ liệu thị trường, thu nhập, tiêu thụ thực phẩm
- Tình trạng sức khỏe: Tình trạng dinh dưỡng, mô hình bệnh tật

72

CÁC CHỈ TIÊU NHÂN TRẮC DINH DƯỠNG THƯỜNG THU THẬP TRONG GIÁM SÁT DINH DƯỠNG

Chỉ tiêu nhân trắc	Đo lường gì	Bối cảnh sử dụng
SDD nhẹ cân	Do SDD cấp và mạn	Thông dụng trong theo dõi tăng trưởng
SDD thấp còi	Thấp so với tuổi	Liên quan tới đói nghèo
SDD gày còm	Cân nặng thấp so với chiều cao	Điều tra trong tình huống khẩn cấp
BMI người lớn	Cân nặng thấp so với chiều cao	Trong bối cảnh ổn định hoặc tình huống khẩn cấp
Cân nặng sơ sinh thấp	Liên quan tới dinh dưỡng bà mẹ kém	Trong bối cảnh ổn định, đánh giá thay đổi dinh dưỡng bà mẹ theo thời gian
BMI người già	Cân nặng thấp so với chiều cao	Tình huống khẩn cấp

73

THỰC TRẠNG GIÁM SÁT THIẾU VI CHẤT DINH DƯỠNG

- Hầu hết là giám sát trọng điểm với mục đích đánh giá độ bao phủ và tác động: muối I ốt, thiếu máu, thiếu vitamin A.
- Dữ liệu quốc gia thiếu vi chất dinh dưỡng thường có ít hơn so với nhân trắc dinh dưỡng trẻ em.
- Hầu như không có hoặc rất hiếm dữ liệu đại diện quốc gia về thiếu kẽm, bệnh pellagra do thiếu vitamin B3.

74

CÁC CHỈ TIÊU VI CHẤT DINH DƯỠNG THƯỜNG THU THẬP TRONG GIÁM SÁT DINH DƯỠNG

Chỉ tiêu nhân trắc	Đo lường gì	Bối cảnh sử dụng
Thiếu máu thiếu sắt	Biểu hiện lâm sàng và Hb,	Bối cảnh ổn định: phụ nữ tuổi sinh đẻ, trẻ dưới 5 tuổi, trẻ học đường
Thiếu vitamin A	Biểu hiện lâm sàng và Retinol huyết thanh	Bối cảnh ổn định và tình huống khẩn cấp
Thiếu I ốt	Biểu hiện lâm sàng và nồng độ I ốt niệu	Bối cảnh ổn định nơi có nguy cơ cao thiếu I ốt
Thiếu vitamin C	Dấu hiệu lâm sàng	Tình huống khẩn cấp
Thiếu vitamin B1	Dấu hiệu lâm sàng	Tình huống khẩn cấp, nơi người dân ăn gạo
Thiếu niacin	Dấu hiệu lâm sàng	Tình huống khẩn cấp khi có ca bệnh được phát hiện, nơi người dân ăn ngô

75

GIÁM SÁT THIẾU VI CHẤT TRONG TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP

- Từng có các vụ dịch thiếu vi chất tại các trại tị nan: scurvy, pellagra, beri-beri, viêm miệng (angular stomatitis).
- Giám sát thiếu vi chất chỉ được thực hiện một khi có vụ dịch xảy ra.
- Khi đã được phát hiện, thường được giải quyết khá nhanh bằng cách cung cấp khẩu phần giàu vi chất.

76

SỬ DỤNG THÔNG TIN DINH DƯỠNG TỪ GIÁM SÁT DINH DƯỠNG

- Thông tin dinh dưỡng có từ giám sát dinh dưỡng thường được sử dụng chưa tốt, lý do:
  - Quan niệm chưa đúng về bản chất và nguyên nhân của suy dinh dưỡng
  - Thể chế của hệ thống giám sát
  - Mức độ phân tích và sự sẵn có của các nguồn lực
  - Tính dễ dàng đáp ứng với thông tin

Cùng phân tích ở các slide sau

77

QUAN NIỆM CHƯA ĐÚNG VỀ BẢN CHẤT VÀ NGUYÊN NHÂN CỦA SUY DINH DƯỠNG

- Thường gặp tại tuyến xã, huyện: Bà mẹ có kiến thức kém lại là nguyên nhân gây SDD trẻ em, hơn là do mất an ninh lương thực hộ gia đình hay bệnh tật của trẻ.
- Hầu hết các hệ thống giám sát dinh dưỡng được thiết kế khi chưa có một khung khái niệm về nguyên nhân SDD hoặc có một khung khái niệm sai, cho rằng có một nguyên nhân nào đó nổi trội hơn nguyên nhân khác: Ví dụ, nhận thức sai lầm cho rằng thiếu lương thực là nguyên nhân chủ yếu của SDD.

78

THỂ CHẾ CỦA HỆ THỐNG GIÁM SÁT

- Thiếu trách nhiệm với các vấn đề dinh dưỡng ở cấp quốc gia: thiếu quan tâm, thiếu nhu cầu về các thông tin dinh dưỡng.
- Sự liên kết giữa các cơ quan chưa tốt: giữa cơ quan cung cấp thông tin và người ra quyết định.
- Có nhiều nguyên nhân gây SDD, do đó cần phối hợp liên ngành: giảm nghèo, đảm bảo an ninh lương thực, can thiệp y tế, xã hội. Nhưng các cơ quan chịu trách nhiệm cho các vấn đề trên lại không chịu trách nhiệm về vấn đề dinh dưỡng, do đó họ không cần thông tin dinh dưỡng.

79

MỨC ĐỘ PHÂN TÍCH VÀ SỰ SẴN CÓ CỦA CÁC NGUỒN LỰC

- Phân tích và thu thập dữ liệu cấp địa phương là công cụ để huy động các nguồn lực ở cấp cộng đồng, cấp quốc gia.
- Nhiều khi thông tin có được từ giám sát trọng điểm lại không liên kết được với các nguồn lực từ cấp quốc gia, quốc tế, do đó làm hạn chế vai trò của thông tin dinh dưỡng.

80

SỰ DỄ DÀNG TRONG ĐÁP ỨNG VỚI THÔNG TIN

- Bổ sung vi chất, tăng cường vi chất vào thực phẩm thu hút được sự chú ý của cộng đồng và nguồn lực của nhà tài trợ, vì nó là giải pháp mang tính kỹ thuật và theo ngành dọc từ cấp trên xuống cấp dưới.
- Điều đó dẫn tới sự giảm cam kết quốc tế để giải quyết SDD protein năng lượng, liên quan tới đói nghèo, khả năng tiếp cận kém tới dịch vụ y tế và giáo dục.

81

ĐÁP ỨNG VỚI THÔNG TIN DINH DƯỠNG TRONG TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP

- Nguồn lực hỗ trợ thuộc về các tổ chức quốc tế.
- Nhiều khi, thông tin dữ liệu dinh dưỡng cho thấy cần tiến hành can thiệp khẩn cấp, nhưng lại không có được đáp ứng thích hợp.
- Lý do là: dữ liệu thiếu tin cậy, thiếu nguồn lực, thời gian huy động nguồn lực kéo dài, vấn đề liên quan tới chính sách ngoại giao, chính trị quốc tế.

82

NGUYÊN NHÂN LÀM GIẢM CHỨC NĂNG CỦA GIÁM SÁT DINH DƯỠNG (1)

- Không hiệu quả
- Chi phí đắt đỏ
- Thiếu tính bền vững

Cùng phân tích ở các slide sau

83

NGUYÊN NHÂN LÀM GIẢM CHỨC NĂNG CỦA GIÁM SÁT DINH DƯỠNG (2)

- Không hiệu quả
  - Thông tin giám sát dinh dưỡng không được dùng để xây dựng chính sách hay đưa ra quyết định
  - Thông tin được lựa chọn tồi, không thích hợp, không kịp thời.
  - Hậu quả dẫn đến là: mất độ tin cậy, không nhận được sử ủng hộ của người ra quyết định, đổ vỡ hệ thống giám sát sau 1 vài năm hoạt động, giảm sự nhiệt tình của người cung cấp dữ liệu sơ cấp.

84

NGUYÊN NHÂN LÀM GIẢM CHỨC NĂNG CỦA GIÁM SÁT DINH DƯỠNG (3)

- Chi phí đắt đỏ
  - Cần có kinh phí cho việc thu thập và xử lý dữ liệu.
  - Khoản chi trực tiếp nói trên ít được chấp nhận khi triển khai giám sát, trong thực tế được thực hiện cùng với việc thu thập dữ liệu

85

NGUYÊN NHÂN LÀM GIẢM CHỨC NĂNG CỦA GIÁM SÁT DINH DƯỠNG (4)

- Thiếu tính bền vững
  - Không nhận được sự ủng hộ của người ra quyết định
  - Sự giảm động lực từ người cung cấp dữ liệu sơ cấp

86

THU THẬP SỐ LIỆU GIÁM SÁT TẠI CÁC NƯỚC KÉM PHÁT TRIỂN

- Vùng nông thôn, miền núi, hải đảo: không có tín hiệu điện thoại hoặc yếu.
- Nhiều nơi không có máy tính, việc theo dõi dữ liệu tăng trưởng trẻ em hàng tháng được ghi chép vào giấy rồi chuyển tới trung tâm y tế huyện và được nhập tại huyện, tỉnh, hoặc trung ương.
- Thời tiết xấu có thể cản trở việc đối chiếu dữ liệu từ các địa điểm điều tra ở những làng/xã xa xôi.

87

NGUỒN DỮ LIỆU GIÁM SÁT (1)

- Dữ liệu sơ cấp: Lấy từ điều tra quốc gia, 3, 5 hoặc 10 năm tiến hành 1 lần, thông tin về TTDD, tiêu thụ lương thực, thực phẩm, tình trạng sức khỏe liên quan tới dinh dưỡng.
- Dữ liệu thứ cấp: Lấy số liệu từ thống kê y tế, điều tra ngân sách hộ gia đình, điều tra nghiên cứu thị trường, điều tra ngành công nghiệp.

88

NGUỒN DỮ LIỆU GIÁM SÁT (2)

Lĩnh vực	Nguồn dữ liệu	Nhận xét
Cung cấp thực phẩm	Điều tra kinh tế y tế (hộ GĐ) Cân đối thực phẩm (quốc gia)	Gồm cung cấp thực phẩm hộ gia đình và quốc gia
Tiêu thụ thực phẩm	Điều tra dinh dưỡng trẻ em, người lớn Thiếu dữ liệu các nhóm thực phẩm như rau, trái cây	Gồm tất cả thức ăn, đồ uống, tăng cường, thực phẩm chức năng, TP bổ sung, sữa mẹ
Mô hình ăn uống	Điều tra dinh dưỡng	Phân tích về chất lượng bữa ăn
Khẩu phần dinh dưỡng	Điều tra dinh dưỡng dùng bảng TP thực phẩm	Cần cập nhật dữ liệu cơ sở về thành phần thực phẩm.

89

NGUỒN DỮ LIỆU GIÁM SÁT (3)

Lĩnh vực	Nguồn dữ liệu	Nhận xét
Tình trạng DD	Điều tra dinh dưỡng & sức khỏe trẻ em và người lớn	Nhân trắc, hóa sinh
TT sức khỏe liên quan tới DD	Điều tra dinh dưỡng & sức khỏe	Bệnh tim, đái tháo đường, tăng huyết áp, béo phì, mỡ máu
An ninh thực phẩm	Điều tra dinh dưỡng, tiêu thụ thực phẩm, điều tra quảng cáo và tiếp thị	Thực phẩm ưa thích, thực hành chế biến, kích cỡ thực phẩm, KAP người tiêu dùng

90

NGUỒN DỮ LIỆU GIÁM SÁT (4)

Lĩnh vực	Nguồn dữ liệu	Nhận xét
Tình trạng thay đổi	Điều tra dinh dưỡng	Ý định thay đổi chế độ ăn, thuận lợi và khó khăn khi thay đổi chế độ ăn
Kết nối với nguy cơ và yếu tố bảo vệ khác	Điều tra hành vi sức khỏe	Sử dụng thuốc lá, rượu bia, hoạt động thể lực, thực hành chăm sóc trẻ nhỏ

THE END